XUẤT HUYẾT
BA THÁNG ĐẦU THAI KỲ

Ths Bs: Lê Đoàn Vũ

Nguyên nhân

1. Thai nghén thất bại sớm
2. Thai ngoài tử cung
3. Bệnh lý nguyên bào nuôi
4. Xuất huyết làm tổ
5. Các nguyên nhân khác: từ cổ tử cung, âm đạo…

Know the Differences

Implantation Bleeding

1. Flow



2. Timing

9

days after ovulation

3. Duration

1-2

days

4. Color



Period

1. Flow



2. Timing

14

days after ovulation

3. Duration

4-7

days

4. Color



Tiền sử

Tiền sử sản, phụ khoa:

- Tiền sử mang chuyển đoạn nhiễm sắc thể, hội chứng kháng phospholipid, dị tật tử cung
- Tiền sử thai ngoài tử cung và phương pháp điều trị thai ngoài tử cung, tình trạng viêm vùng chậu di chứng *Chlamydia trachomatis,* phẫu thuật vòi trứng, STDs
- Hiếm muộn, ART
- Mổ lấy thai
- Tránh thai, kinh nguyệt

Bệnh sử

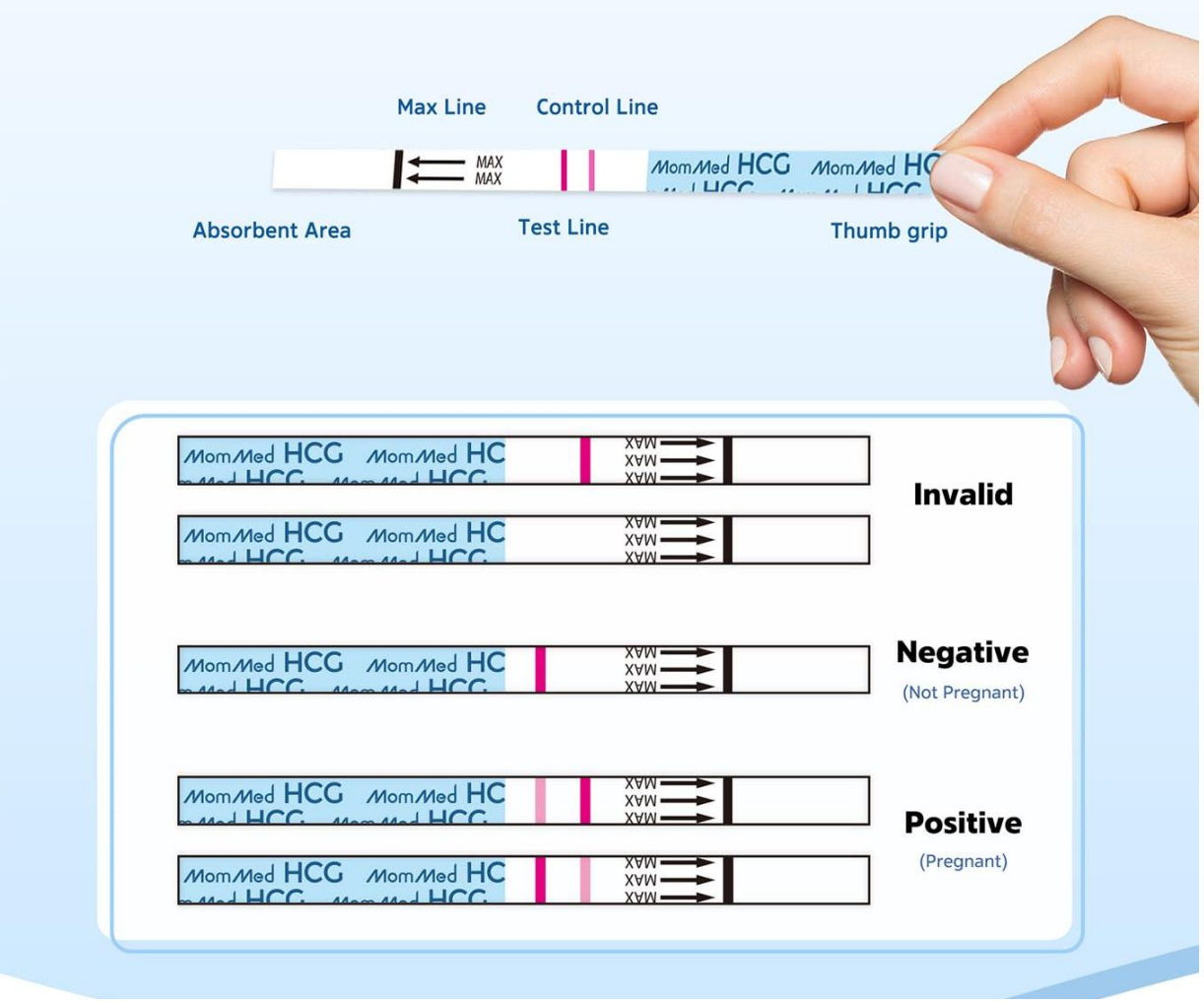
- Kinh chót
- Chảy máu
  - Máu mất thường là máu mẹ.
  - Bắt đầu, mức độ, kiểu, tính chất máu, hiện diện máu cục hay mô thai.
  - Chảy máu nhiều mức độ: từ xuất huyết điểm (spotting), nhẹ, chảy máu nặng (≥ 1-2 băng vệ sinh/ giờ trong 2 giờ hoặc cục máu đông ≥ 1 inch)
  - Có thể kèm đau bụng

Bệnh sử

- Ngất: Hạ huyết áp tư thế
- Triệu chứng thai nghén
- β-hCG định tính

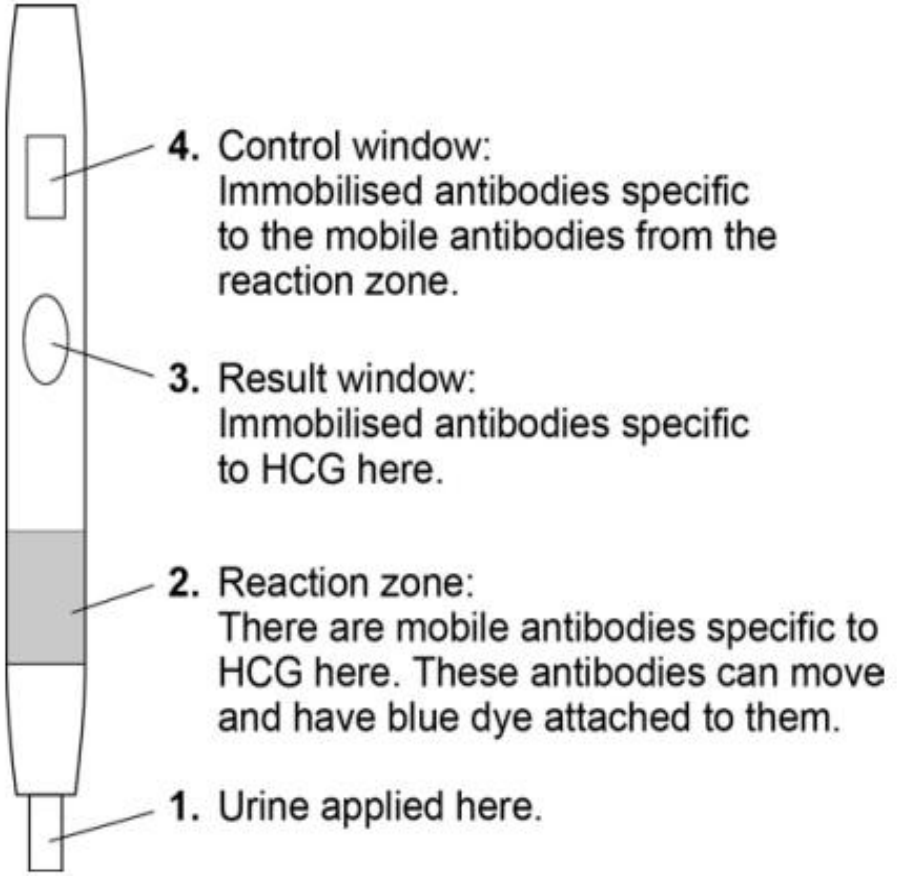
βhCG định tính

- Không thay đổi trong ngày
- Phụ thuộc vào lưu lượng
- Chỉ có hoạt tính khi ở trạng thái đầy đủ
- Hoạt năng lá nuôi



βhCG định tính

Figure 9



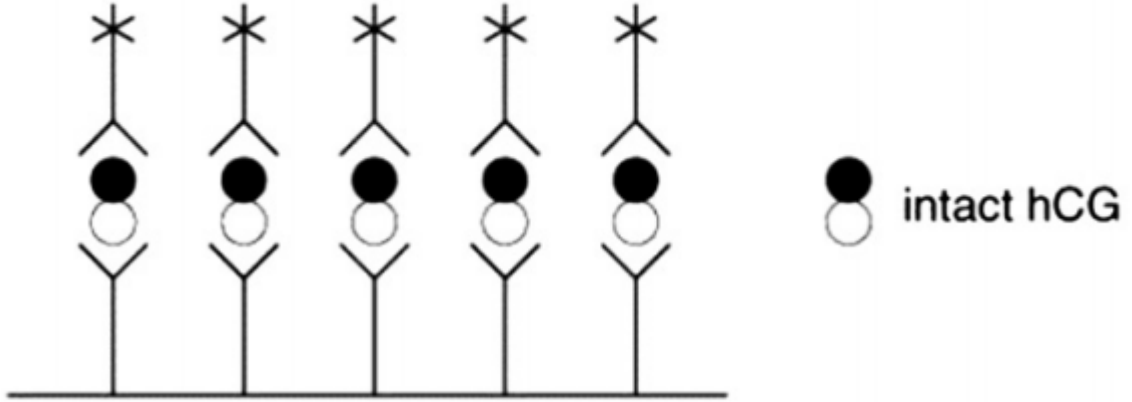
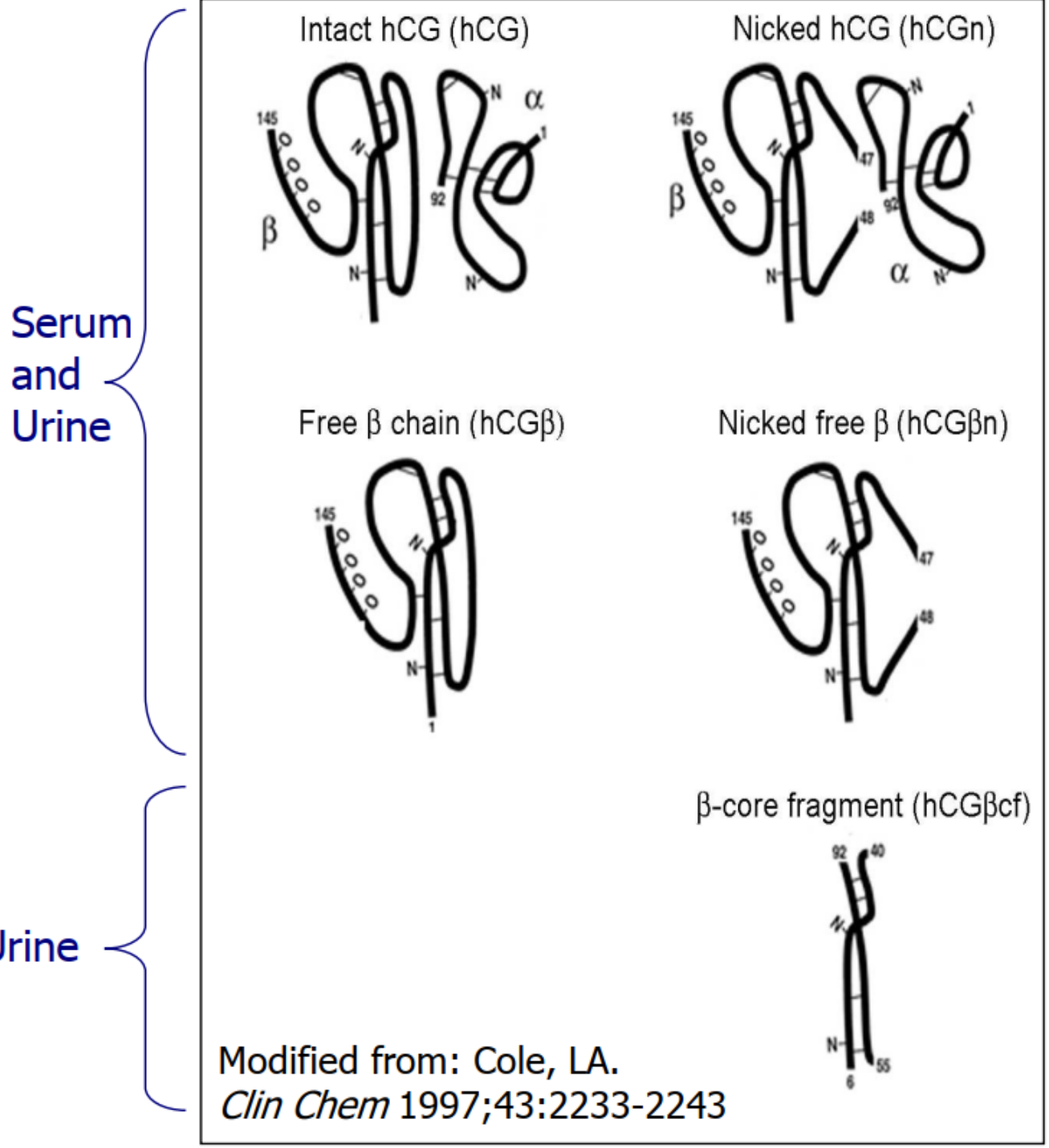


Figure 2. Sandwich assay schematic demonstrating a normal positive test. Molecules of intact human chorionic gonadotropin (hCG) are recognized by both solid-state antibodies fixed to a matrix and by soluble free-floating antibodies with an affixed reporter label to form a "sandwich," resulting in a positive test.

Xem video

- Numerous molecular forms of hCG present in pregnancy serum
  - Dissociated or degraded molecules with no biological activity
- Key β-containing variants
  - Intact hCG
  - Nicked hCG
  - Free β subunit
  - Nicked free β subunit
  - β-core fragment (urine)



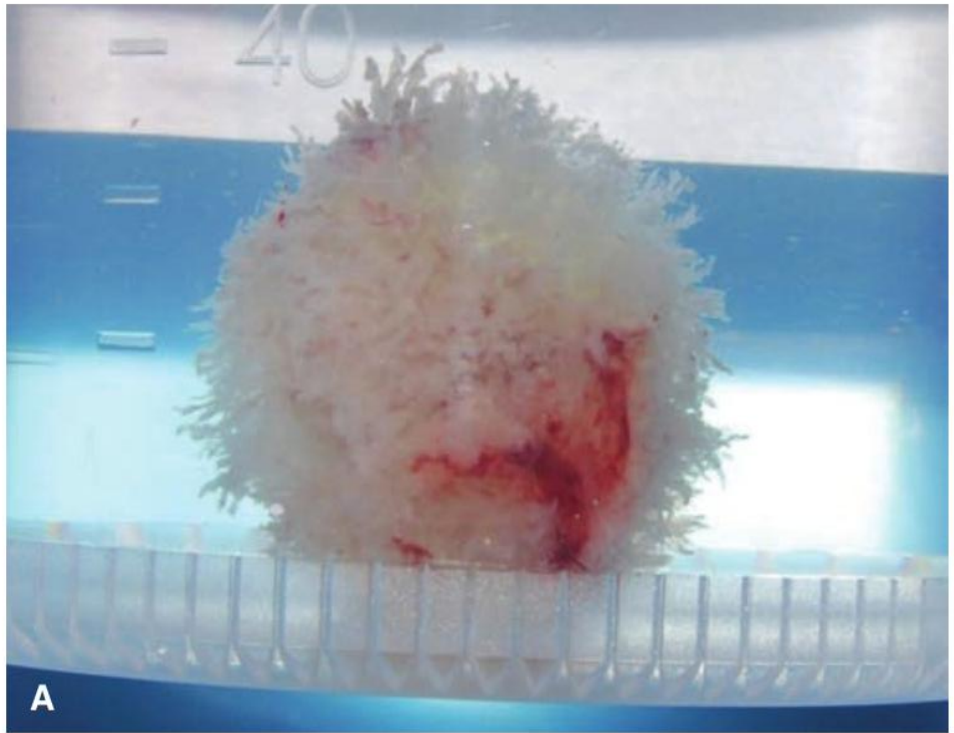
Triệu chứng thực thể

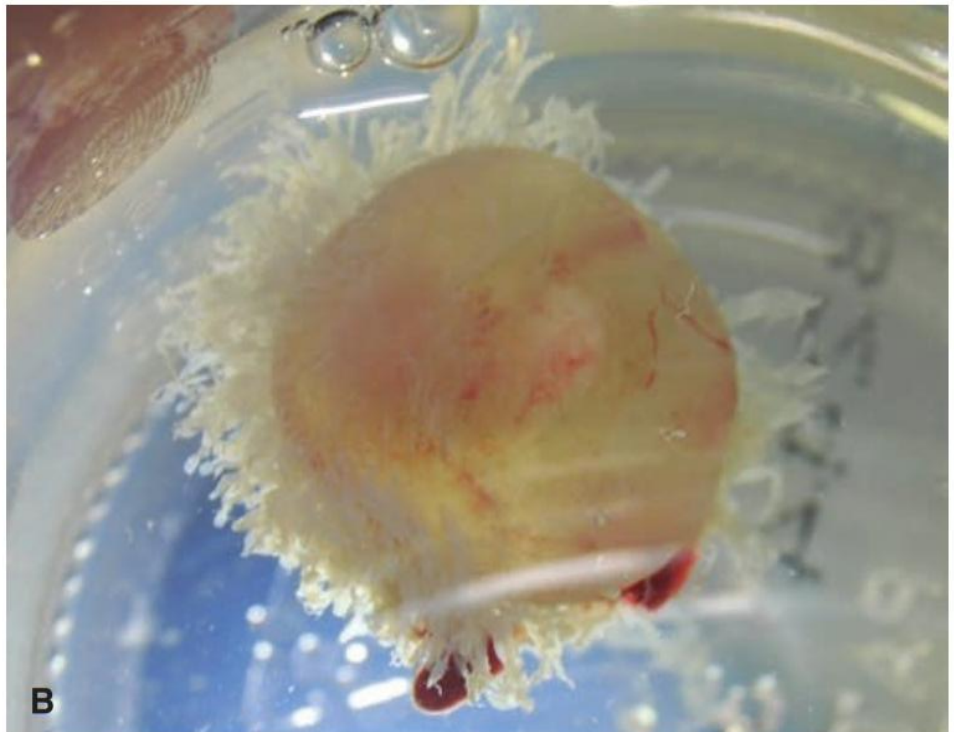
- Đánh giá sinh hiệu
- Khám bụng: Dấu phúc mạc trong xuất huyết nội
- Khám ngoài
- Khám sản phụ khoa

- Khám mỏ vịt:
  - Nhẹ nhàng: đánh giá nguồn gốc chảy máu, tính chất, mức độ và diễn tiến
  - Nếu có khối mô nghi ngờ túi thai/ màng thai tống xuất được đánh giá kĩ lưỡng, giải phẫu bệnh để xác định

Triệu chứng thực thể

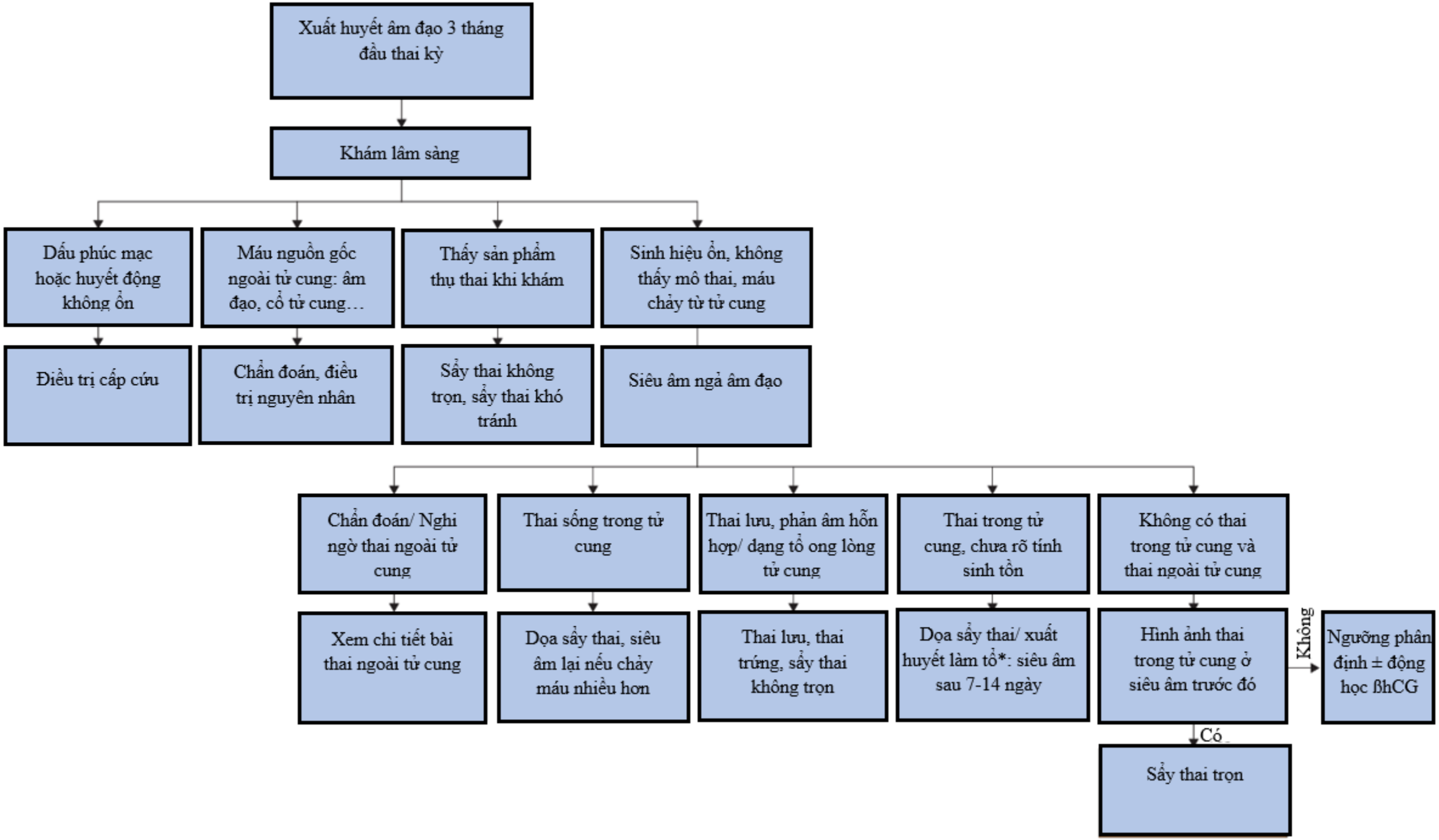
- Nếu có khối mô nghi ngờ túi thai/ màng thai tống xuất được đánh giá kĩ lưỡng, và phân biệt với máu cục bằng cách rửa loại bỏ máu cục và quan sát trong nước. Khối mô gửi giải phẫu bệnh để chẩn đoán xác định.





Triệu chứng thực thể

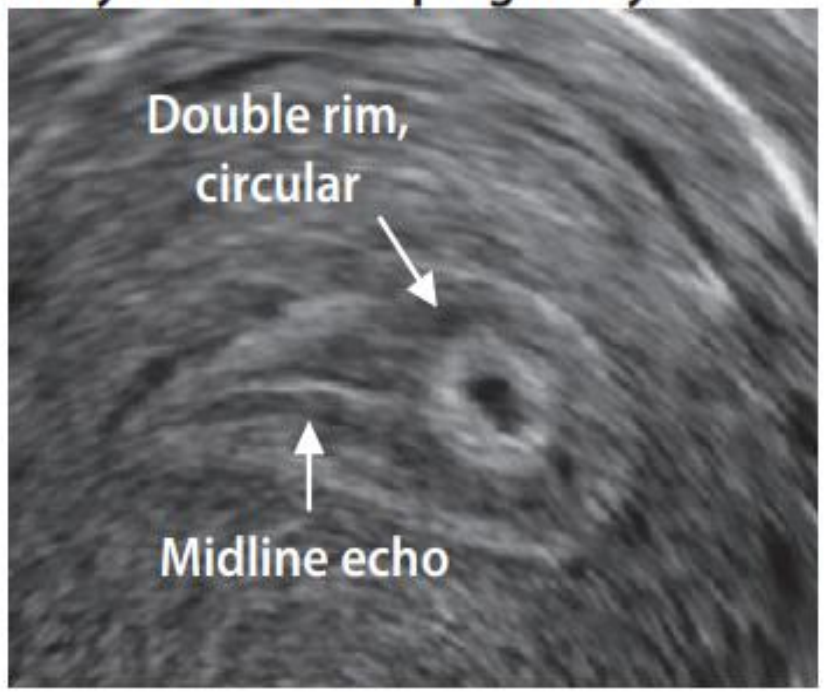
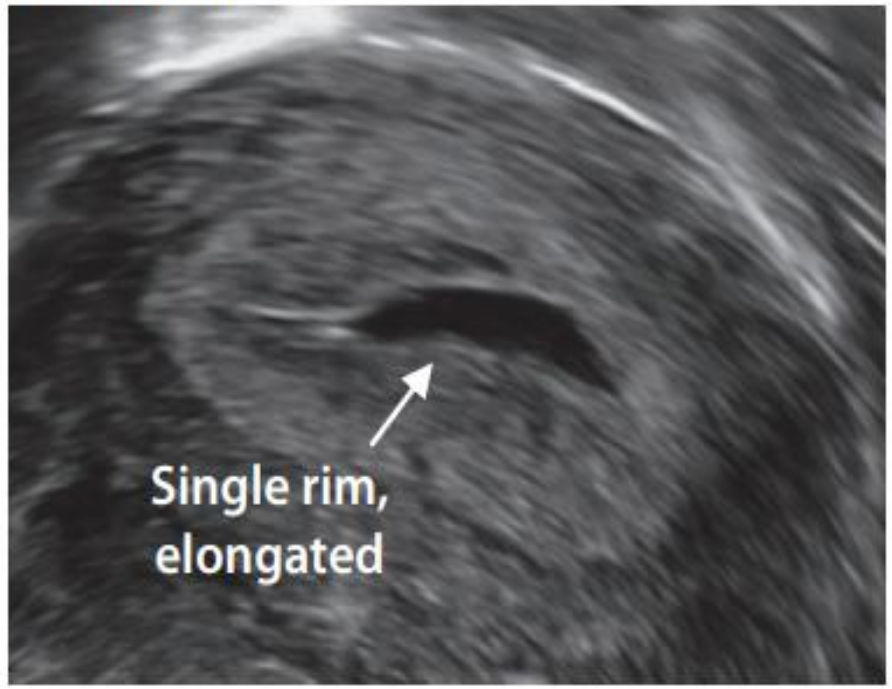
- Lỗ trong cổ tử cung
  - Mở: sẩy thai khó tránh, sẩy thai không trọn.
  - Đóng: thai ngoài tử cung, dọa sẩy thai, xuất huyết làm tổ hoặc sẩy thai trọn. Lưu ý lỗ ngoài cổ tử cung mở ít có giá trị vì là biến thể bình thường đặc biệt người con rạ.
- Chadwick sign, Goodell sign
- Tử cung: Hegar sign, kích thước, đau
- Phần phụ: u/ nang hoàng tuyến, đau/ thai ngoài tử cung.
- Cùng đồ sau ấn đau trong trường hợp xuất huyết nội.


Xuất huyết âm đạo 3 tháng đầu thai kỳ
Khám lâm sàng
Dấu phúc mạc hoặc huyết động không ổn
Máu nguồn gốc ngoài tử cung: âm đạo, cổ tử cung…
Thấy sản phẩm thụ thai khi khám
Sinh hiệu ổn, không thấy mô thai, máu chảy từ tử cung
Điều trị cấp cứu
Chẩn đoán, điều trị nguyên nhân
Sẩy thai không trọn, sẩy thai khó tránh
Siêu âm ngả âm đạo
Chẩn đoán/ Nghi ngờ thai ngoài tử cung
Thai sống trong tử cung
Thai lưu, phản âm hỗn hợp/ dạng tổ ong lòng tử cung
Thai trong tử cung, chưa rõ tính sinh tồn
Không có thai trong tử cung và thai ngoài tử cung
Xem chi tiết bài thai ngoài tử cung
Dọa sẩy thai, siêu âm lại nếu chảy máu nhiều hơn
Thai lưu, thai trứng, sẩy thai không trọn
Dọa sẩy thai/ xuất huyết làm tổ*: siêu âm sau 7-14 ngày
Hình ảnh thai trong tử cung ở siêu âm trước đó
Không
Ngưỡng phân định ± động học βhCG
Có
Sẩy thai trọn

Cận lâm sàng- siêu âm

- Là tiếp cận sơ cấp: vị trí thai, số lượng thai, tính sinh tồn, tuổi thai, dị tật thai.
- Tần số cao ≈ độ phân giải
- Tần số thấp ≈ phạm vi quan sát
- Ngã âm đạo: 5-10 MHz
- Ngã bụng: TCN 2: 4- 6 MHz, TCN 3: 2-5 MHz
- Siêu âm/ âm đạo có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn so với siêu âm ngả bụng. Siêu âm đường bụng giúp đánh giá dịch trong ổ bụng, vị trí thai ổ bụng, thai ở gan…

Table 3.1. Ultrasound differentiation between an early intrauterine gestational sac and a pseudosac

Characteristic / Ultrasound image	Early intrauterine pregnancy	Pseudosac
		
LOCATION	Below midline, buried into decidua	Midline, between endometrial layers
SHAPE	Circular and steady	Elongated, varies during scan
BORDER	Echogenic rim (double)	Single decidual layer
COLOR FLOW	High peripheral flow	Avascular



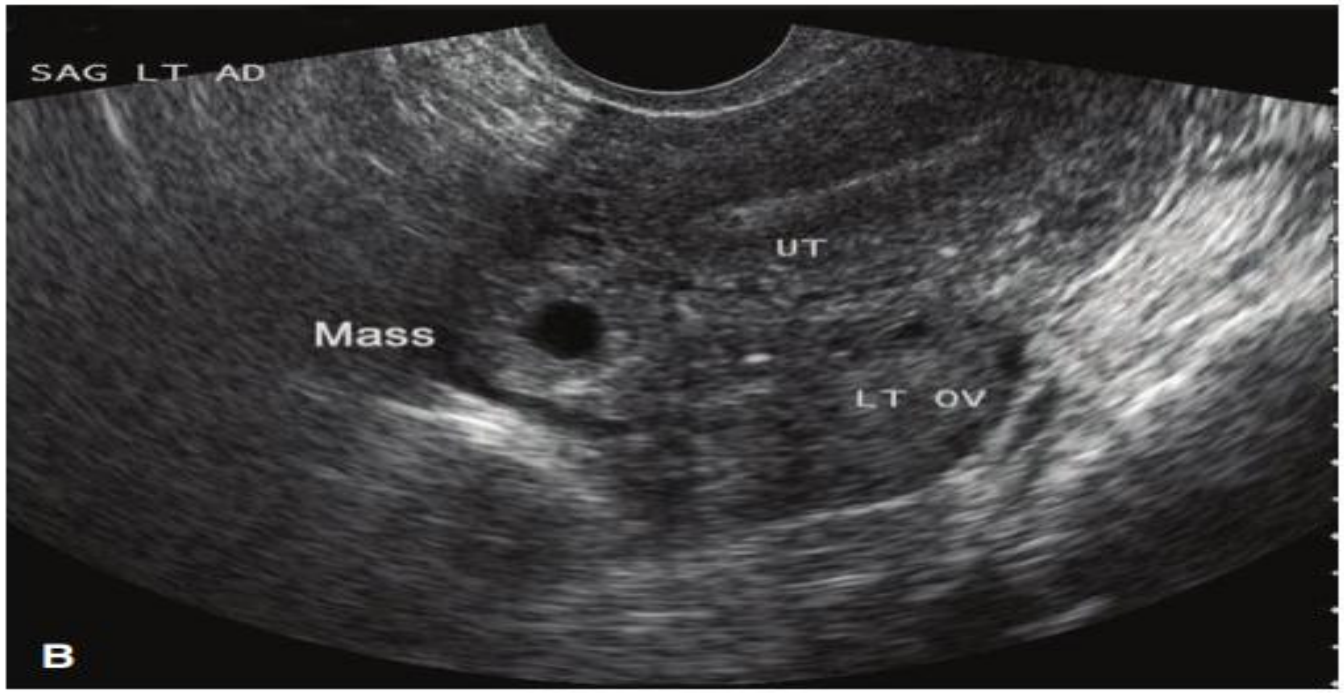
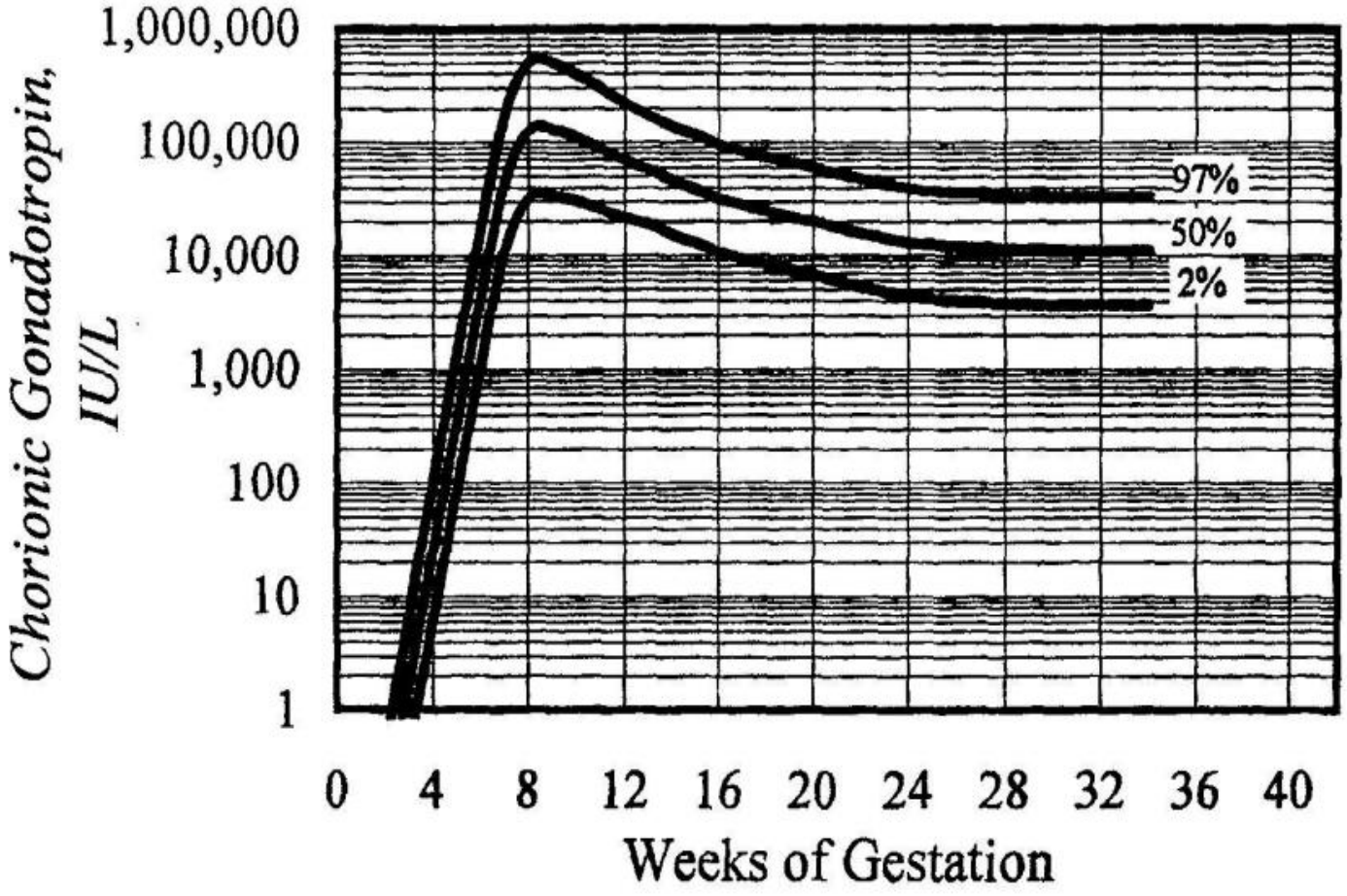




FIGURE 12-4 Various transvaginal sonographic findings with ectopic tubal pregnancies. For sonographic diagnosis, an ectopic mass should be seen in the adnexa separate from the ovary and may be seen as: **(A)** a yolk sac (shown here) and/or fetal pole with or without cardiac activity within an extrauterine sac, **(B)** an empty extrauterine sac with a hyperechoic ring, or **(C)** an inhomogeneous adnexal mass. In this last image, color Doppler shows a classic "ring of fire," which reflects increased vascularity typical of ectopic pregnancies. LT OV = left ovary; SAG LT AD = sagittal left adnexal; UT = uterus.

Cận lâm sàng- β-hCG

- Chẩn đoán thai sớm.
- Khi thai trong tử cung bình thường thì βhCG ít giá trị
- Ngưỡng phân định, động học βhCG là khảo sát thứ cấp



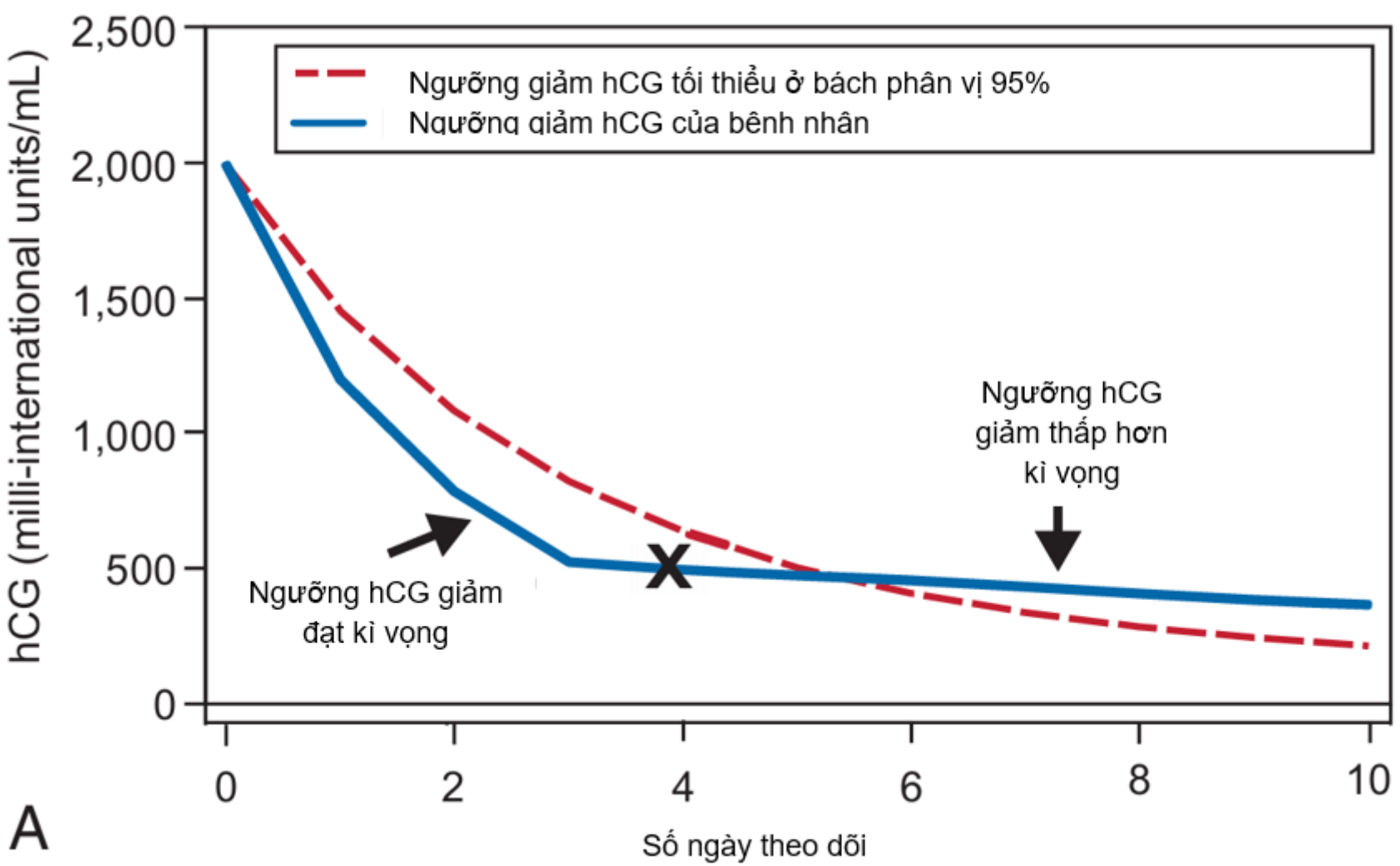
Ngưỡng phân định của βhCG

- Kết hợp TVS và β-hCG để xác định vị trí thai
- Là giá trị 99 per thai trong tử cung thấy được/ siêu âm.
- Phụ thuộc loại đầu dò, thành bụng, nhân xơ tử cung…
  - 1500 mUI/ml/ TVS cho đơn thai
  - 3000 mUI/ml/ TVS cho song thai
  - 5000 mUI/ml/ TAS cho đơn thai
  - 3500 mUI/ml cân nhắc/ BN mong con
- PUL: dưới ngưỡng cắt và chưa xác định vị trí thai

Động học - βhCG

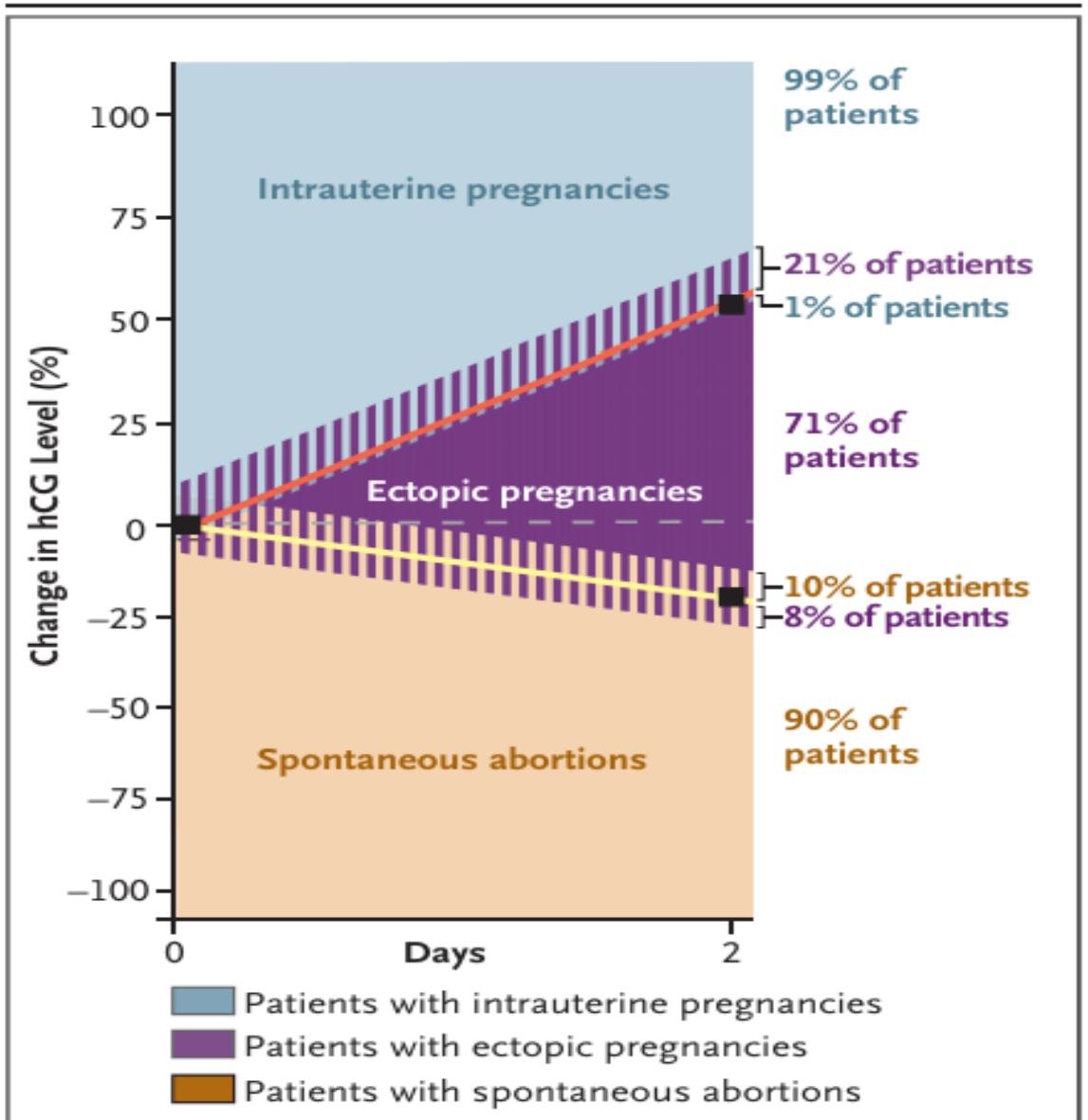
- Một giá trị β-hCG không xác định được vị trí thai. Cần đánh giá nồng độ β-hCG 48 giờ sau: động học
- Mức tăng tối thiểu: Là giá trị 99 per thai trong tử cung bình thường đạt mức này
- Mức tăng tối thiểu/thai trong tử cung bình thường tùy vào ngưỡng β-hCG ban đầu.

- Tăng 49%: < 1500 IU/L
- Tăng 40%: 1500- 3000 IU/L
- Tăng 33%: >3000 IU/L.


Ngưỡng giảm hCG tối thiểu ở bách phân vị 95%
Ngưỡng giảm hCG của bệnh nhân
hCG (milli-international units/mL)
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
0
2
4
6
8
10
Số ngày theo dõi
Ngưỡng hCG giảm đạt kì vọng
Ngưỡng hCG giảm thấp hơn kì vọng
A

Động học - βhCG

- Động học tăng dưới ngưỡng tối thiểu: TNTC hay thai trong tử cung diễn biến bất thường
- Động học giảm dưới ngưỡng có thể là thai ngoài tử cung hay thai sẩy thai không trọn.



Bước 1: Phân loại bệnh cấp cứu

Loại trừ các tình trạng đe dọa tính mạng như thai ngoài tử cung vỡ, sẩy thai/ thai bám vết mổ cũ kèm chảy máu nặng, sẩy thai nhiễm trùng gây sốc nhiễm trùng.

- Gọi người hỗ trợ, chẩn đoán + xử trí đồng thời
- Khai thác bệnh sử, tiền sử ngắn gọn trọng tâm
- Đánh giá nhanh sinh hiệu, da niêm, bụng ngoại khoa
- Lập 2 IV lớn, xét nghiệm Hct, đông máu, nhóm máu, thực hiện phản ứng chéo, truyền máu khi cần thiết.
- βhCG định tính, siêu âm tại giường

Bước 2: Xác định AUB

Kết hợp cả 2 yếu tố sau

1. Từ tử cung
   - Loại trừ máu từ đáy chậu, âm hộ, tiền đình, âm đạo, CTC
   - Thấy máu chảy ra từ lỗ cổ tử cung
   - Đánh giá tính chất, mức độ và diễn tiến
2. Tính chất bất thường: Thể tích, thời gian, tần suất, tính đều đặn

Bước 2: Xác định AUB

Đặc điểm	Bình thường	Bất thường
Tần số	Không có (không chảy máu) = vô kinh	
	Không thường xuyên (> 38 ngày)	
	Bình thường (≥ 24 và ≤ 38 ngày)	
	Thường xuyên (< 24 ngày)	
Thời gian	Bình thường (≤ 8 ngày)	
	Kéo dài (> 8 ngày)	
Mức độ đều đặn	Bình thường hay đều đặn (chu kì ngắn nhất đến dài nhất lệch < 7 – 9 ngày)*	
	Không đều đặn (chu kì ngắn nhất đến dài nhất lệch ≥ 8 - 10 ngày)	
Lượng máu mất (bệnh nhân xác định)	Ít	
	Bình thường	
	Nặng	

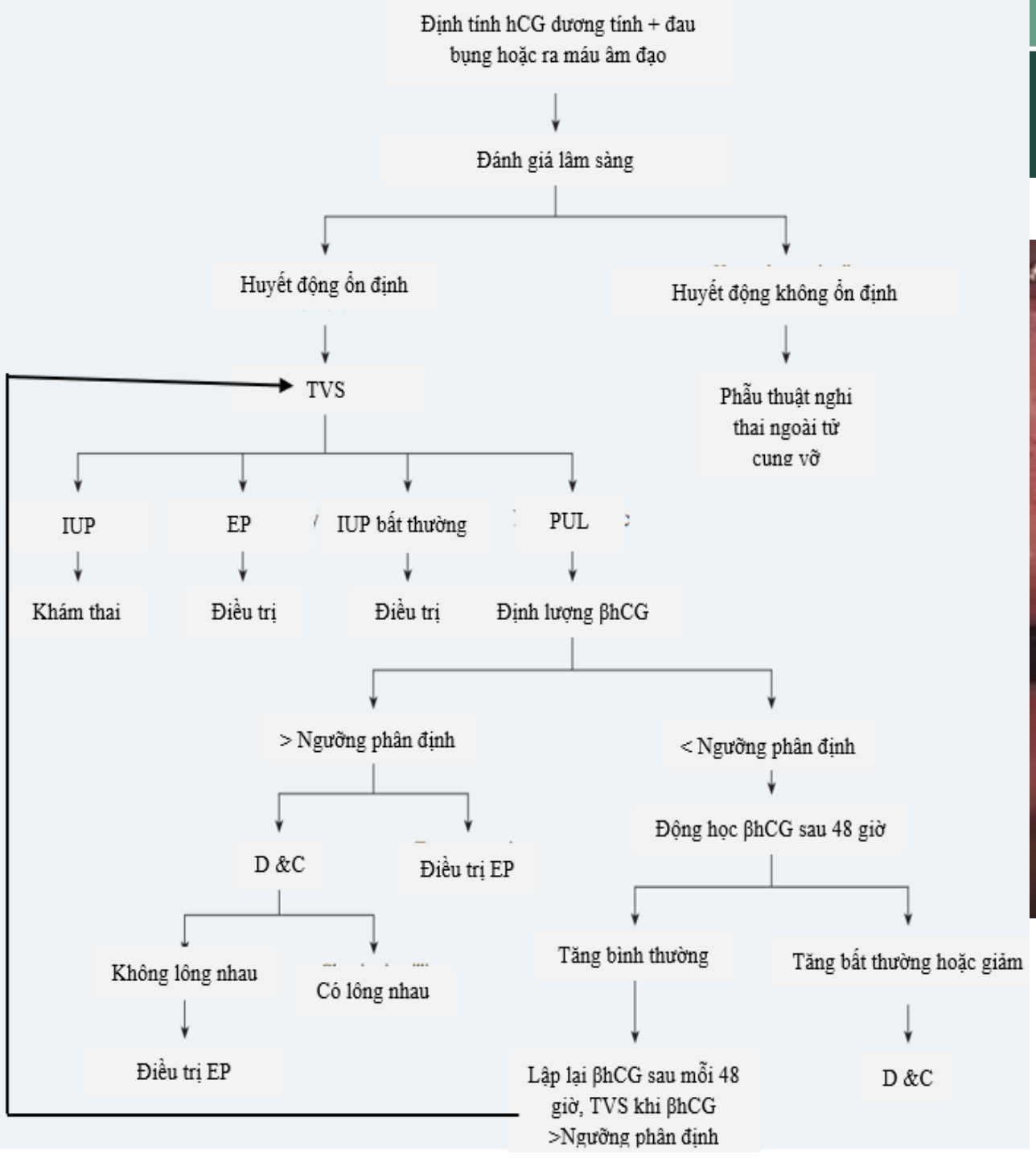
Xuất huyết giữa chu kì (chảy máu giữa chu kì đều đặn)	Không có	
	Ngẫu nhiên	
	Chu kì (có thể đoán được)	Đầu chu kì
		Giữa chu kì
		Cuối chu kì

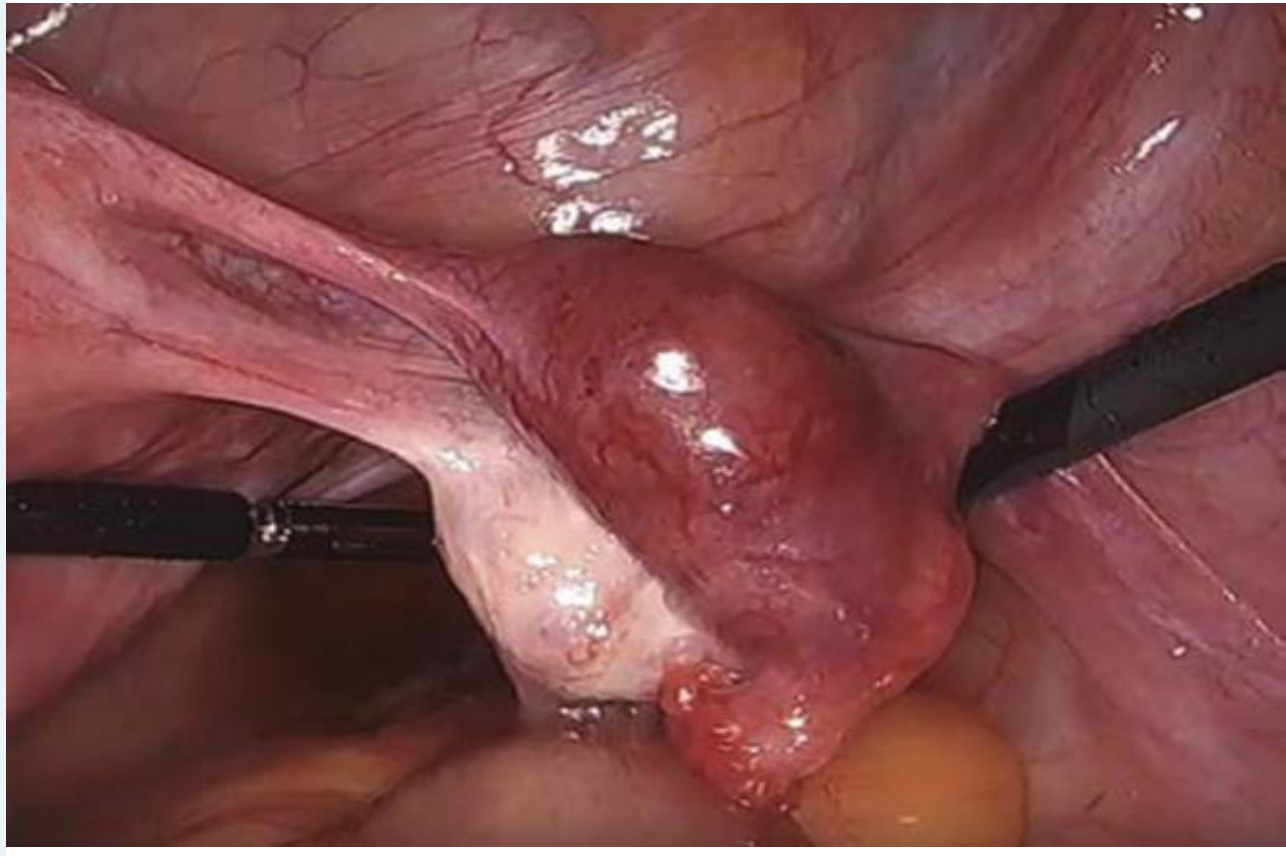
Chảy máu đột xuất do thuốc Progestin ± Estrogen (Thuốc tránh thai, vòng, miếng dán, tiêm)	Không áp dụng được (không sử dụng thuốc nội tiết)
	Không có (sử dụng thuốc nội tiết)
	Hiện diện

Bước 3: Loại trừ AUB liên quan thai kỳ

- Loại trừ các nguyên nhân xuất huyết liên quan đến thai kỳ
- Bệnh sử, tiền sử, khám lâm sàng, cận lâm sàng




Định tính hCG dương tính + đau bụng hoặc ra máu âm đạo
Đánh giá lâm sàng
Huyết động ổn định
Huyết động không ổn định
TVS
Phẫu thuật nghi thai ngoài tử cung vỡ
IUP
EP
IUP bất thường
PUL
Khám thai
Điều trị
Điều trị
Định lượng βhCG
> Ngưỡng phân định
< Ngưỡng phân định
D &C
Điều trị EP
Động học βhCG sau 48 giờ
Không lông nhau
Có lông nhau
Tăng bình thường
Tăng bất thường hoặc giảm
Điều trị EP
Lập lại βhCG sau mỗi 48 giờ, TVS khi βhCG >Ngưỡng phân định
D &C



CẢM ƠN LẮNG NGHE CÁC ANH CHỊ